临床试验 档案 B 演示数据 完整度 13/18 无匹配度百分比

入组档案 完整度 13/18 · 全部来自既有病情数据

完整度是"本档案有记录的字段数 / 本页会用到的字段数"，不是分数、不是匹配度；缺的字段会让对应条件显示「无法判定」。

> 本次比对会用到但缺失：确诊日期 · 激酶区突变 · ECOG 体能评分 · 脂肪酶 / 淀粉酶 · 心电图 QTc —— 这些条件一律判「无法判定」，不会因为没记录就算满足。

基本

年龄	31 岁
性别	女
病种与分期	慢性期（CP）
确诊日期	（未记录）

基因分子

BCR::ABL1 转录本类型	e13a2（典型）
激酶区突变	（未记录）
检测方法与标本	典型转录本
基因检测报告日期	2020-03-11

病理

细胞遗传学（Ph 染色体 / 附加异常）	Ph+（t9;22）

治疗史

既往 TKI 线数	2 线（伊马替尼 → 尼洛替尼）
当前用药与剂量	（停药观察） — none

体能

ECOG 体能评分	（未记录）

器官功能

肝功能（ALT / 总胆红素）	ALT 62 U/L（2025-11-20，高于参考上限）· 总胆红素 11.0 μmol/L（正常）
脂肪酶 / 淀粉酶	（未记录）
肾功能（肌酐 / eGFR）	肌酐 61 μmol/L · eGFR 102 mL/min（2026-10-08 生化）
心电图 QTc	（未记录）

其他

妊娠状态	未孕（2026-10 自述；TKI 已停）
主要并发症	肝功能异常（ALT 升高，2025-11 尼洛替尼期间）

CML 的入组条件看的是分期、转录本类型、激酶区突变、既往 TKI 线数与器官功能；**本页不做 IHC 标志物筛选**（IHC 是实体瘤的分型工具，不适用于 CML）。

逐条比对（三档）

规则集 cml-rules-2026.10-1　评估生成 2026-10-25

已满足 **5** 项 · 可能冲突 **1** 项 · 无法判定 **4** 项 · 待确认规则 **1** 项（汇总只计数，不给匹配度）

可能冲突（1）

可能冲突 ALT 与总胆红素在正常上限内
你的记录：ALT 62 U/L（2025-11-20，高于参考上限）· 总胆红素 11.0 μmol/L（正常）
来源：入选标准 6 · 字段：肝功能（ALT / 总胆红素）

无法判定（4）

无法判定 ECOG 0—1
你的记录：（本档案无此记录）
来源：入选标准 5 · 字段：ECOG 体能评分

无法判定 脂肪酶 ≤1.5×ULN
你的记录：（本档案无此记录）
来源：入选标准 7 · 字段：脂肪酶 / 淀粉酶

无法判定 QTc <450ms（男）/ <470ms（女）
你的记录：（本档案无此记录）
来源：入选标准 8 · 字段：心电图 QTc

无法判定 排除已知 T315I 突变
你的记录：（本档案无此记录）
来源：排除标准 4 · 字段：激酶区突变

已满足（5）

已满足 年龄 ≥18 岁
你的记录：31 岁
来源：入选标准 1 · 字段：年龄

已满足 慢性期（或加速期，见原文分项）
你的记录：慢性期（CP）
来源：入选标准 2 · 字段：病种与分期

已满足 Ph 染色体阳性 / BCR::ABL1 阳性
你的记录：Ph+（t9;22）
来源：入选标准 3 · 字段：细胞遗传学（Ph 染色体 / 附加异常）

已满足 既往 TKI 治疗线数 ≤2
你的记录：2 线（伊马替尼 → 尼洛替尼）
来源：入选标准 4 · 字段：既往 TKI 线数

已满足 非妊娠期（女性受试者）
你的记录：未孕（2026-10 自述；TKI 已停）
来源：排除标准 3 · 字段：妊娠状态

待确认规则（1）

这些条件原文没能结构化，**不参与上面对比**，需要你或医生对着原文确认。

> **待确认** 试验期间需采取有效避孕措施（原文未结构化）
> 来源：排除标准 5

排序按数据来源顺序，不按匹配度（按匹配度排序等于给推荐）。判定是确定性规则求值：同一份档案 + 同一版规则 = 同一结果，不由模型现算。

> **这不是入组资格判断。**本页只把"该问的问题"整理清楚：哪些条件你的记录看起来不冲突、哪些要再确认什么。入组判断属于医生与研究中心。

试验登记摘录

登记状态，未核实

> 以下为**演示虚构条目**，不是真实临床试验信息；M4 接入 unified-trial-mcp 后整体替换。登记 ≠ 有效 ≠ 安全 ≠ 可入组。

【演示虚构】TKI 停药后分子学复发监测路径研究 DEMO-CML-TFR-01

II 期 · 招募中（演示） · 申办：（演示）某血液病中心

针对已达到深度分子学反应、拟尝试停药的患者，研究停药后监测频率。

渠道：demo · 最后核对 2026-10-25

【演示虚构】T315I 突变阳性患者的第三代 TKI 用药研究 DEMO-CML-T315I-01

I/II 期 · 招募中（演示） · 申办：（演示）某三甲医院血液科

入组条件涉及激酶区突变类型。

渠道：demo · 最后核对 2026-10-25

【演示虚构】二线 TKI 换药后的疗效与安全性观察 DEMO-CML-2L-01

IV 期 · 尚未招募（演示） · 申办：（演示）某省血液病医院

入组条件涉及既往 TKI 治疗线数。

渠道：demo · 最后核对 2026-10-25

【演示虚构】长期服用 TKI 患者的生活质量随访 DEMO-CML-QOL-01

观察性 · 招募中（演示） · 申办：（演示）某患者组织合作项目

不涉及用药调整。

渠道：demo · 最后核对 2026-10-25

本次检索覆盖 **1/1** 个渠道（演示渠道 · 就绪）· 未参与：ICTRP（未配置）· ChiCTR 在线（未配置）· chinadrugtrials（未配置）· 小胰宝归档（本癌种无覆盖）

AI 协助整理问题

只把问题整理成清单：按钮只把提示词填进右上角输入框，**不会自动发送**，也不替你下结论。

AI 协助（示例） · 把比对提示词填进输入框

从哪里进来（场景路径）

分子线趋势页的词表卡给出「临床研究核对字段」入口 → 去分子线趋势与词表；复诊资料包也引用本页字段清单 → 去复诊准备。

… 更多